Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 07:57
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 07:58
Temps mis	1 min 1 s
Points	1,37/5,00
Note	**5,48** sur 20,00 (**27,4**%)

Énoncé général

Vous recevez en consultation Monsieur F.B., 63 ans, pour bilan de dyspnée et douleur thoracique gauche.

- Il a comme antécédents une hypertension artérielle, une artérite oblitérante des membres inférieurs.
- Son traitement à domicile comprend : Amlodipine et Aspirine 75mg.
- Il est fumeur depuis l'âge de 16 ans, un paquet de cigarettes par jour. Il a exercé la profession d'ouvrier dans une usine de fabrication de fibrociment « Eternit » de 21 à 23 ans puis d'agent de sécurité. Il est actuellement retraité.

Il rapporte une dyspnée depuis 2 mois, de majoration progressive, actuellement stade 3 MRC, associée à une toux sèche et une douleur thoracique gauche ne cédant pas sous antalgique de palier I. Il n'y a pas d'altération de l'état général à l'exception d'une asthénie modérée

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,67 sur 1,00

Interpréter la radio graphie thoracique, quelles sont les 3 propositions correctes ?



— 3 réponses sont attendues —

- [x] a. On observe une opacité gauche dense et homogène. ✔
- [x] b. On observe une ligne bordante pleurale. ✔
- [x] c. La coupole diaphragmatique droite est ascensionnée. ✖
- [ ] d. Il s'agit d'un épanchement pleural gauche.
- [ ] e. Il s'agit d'une atélectasie lobaire inférieure gauche.

f. Cette opacité est rétractile.

Vous en avez sélectionné correctement 2.
Les réponses correctes sont : On observe une opacité gauche dense et homogène., On observe une ligne bordante pleurale., Il s'agit d'un épanchement pleural gauche.

Question 2

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quels signes physiques vous attendez-vous à retrouver à l'examen clinique ?

a. Diminution du murmure vésiculaire gauche ✔

b. Matité à la percussion de l'hémithorax gauche ✔

c. Augmentation des vibrations vocales à gauche ✖

d. Souffle pleurétique gauche ✔

e. Sibilants unilatéraux gauche ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Diminution du murmure vésiculaire gauche, Matité à la percussion de l'hémithorax gauche, Souffle pleurétique gauche

---

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Quels sont les 2 examens paracliniques que vous envisagez en première intention ?

— 2 réponses sont attendues —

a. Un bilan biologique avec bilan de coagulation et dosage de LDH sanguin ✔

b. Une fibroscopie bronchique ✖

c. Une ponction pleurale

d. Un scanner thoracique

e. Un TEP-scanner

f. Un Examen Cyto-Bactériologique des Crachats (ECBC)

Vous en avez sélectionné correctement 1.
Les réponses correctes sont : Un bilan biologique avec bilan de coagulation et dosage de LDH sanguin, Une ponction pleurale

---

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La ponction pleurale ramène un liquide séro-hématique. La biochimie du liquide pleural est la suivante :

- Protides pleuraux 48g/L (protidémie 62g/L)
- LDH pleuraux 130 UI/L (LDH sanguin 200 UI/L)

De quel type d'épanchement s'agit-il ?

a. Un exsudat

b. Un transsudat ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Un exsudat

Question 5

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quelles sont les étiologies possibles d'un épanchement exsudatif ?

a. Pleurésie parapneumonique non compliquée ✔

b. Insuffisance ventriculaire gauche ✖

c. Pleurésie maligne ✔

d. Pleurésie tuberculeuse ✔

e. Syndrome oedémato-ascitique ✖

f. Pleurésie médicamenteuse ✔

g. Pleurésie bénigne à l'amiante ✔

h. Syndrome Néphrotique ✖

i. Pleurésie virale ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Pleurésie parapneumonique non compliquée, Pleurésie maligne , Pleurésie tuberculeuse, Pleurésie médicamenteuse, Pleurésie bénigne à l'amiante, Pleurésie virale